OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

# Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS

**ACR Bone-RADS v2023**
radiographie · score par points

**Champ :** lésion osseuse solitaire découverte en radiographie (ou analysée comme telle), chez l'adulte. On additionne les points des 6 critères ; le total donne la catégorie et la conduite. Pour le scanner et l'IRM, un système distinct existe (Society of Skeletal Radiology).

## SCORE PAR POINTS (BONE-RADS V2023)

### Marges (Lodwick)

| | |
|---|---|
| **IA** géographique, bord **scléreux** | **1** |
| **IB** géographique, bien limité, **sans** sclérose | **3** |
| **II** géographique, mal limité | **5** |
| **III A–C** marges changeantes, mitées ou perméatives, ou invisibles | **7** |

### Réaction périostée

| | |
|---|---|
| Aucune | **0** |
| Non agressive : solide, lisse, unilamellaire | **2** |
| Agressive : lamellée (« bulbe d'oignon »), spiculée (« feu d'herbe », « soleil »), éperon de Codman, désorganisée | **4** |

### Érosion endostée

| | |
|---|---|
| Légère | **0** |
| Modérée | **1** |
| Profonde | **2** |

AUTRES CRITÈRES

| | |
|---|---|
| Fracture pathologique | **+2** |
| Masse des parties molles | **+4** |
| Cancer primitif connu | **+2** |

## CATÉGORIES ET CONDUITE

| CATÉGORIE | POINTS | EXEMPLES | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| 0 incomplet | — | Risque non évaluable ; ex. lésion lytique du squelette axial (scapula, rachis, bassin) | Incidences supplémentaires ou imagerie en coupes |
| 1 très faible risque | **1–2** | Lésion bénigne pathognomonique, « à ne pas toucher » : fibrome non ossifiant, ostéome ostéoïde | Asymptomatique : bilan terminé ou surveillance annuelle ; symptomatique : imagerie avancée, avis orthopédique |
| 2 faible risque | **3–4** | Lésion lytique géographique asymptomatique sans réaction périostée suspecte ni érosion profonde ; ex. enchondrome, tumeur à cellules géantes, kyste anévrismal | Contrôle rapproché à **3–6 mois** ; imagerie avancée ± biopsie si besoin ; avis orthopédie oncologique à discuter |
| 3 intermédiaire | **5–6** | Lésion géographique mal limitée ; lésion géographique chez un patient avec cancer connu | **Avis orthopédie oncologique** pour biopsie probable ; scanner, IRM ou scintigraphie |
| 4 haut risque | **≥ 7** | Lésion non géographique, ou géographique avec réaction périostée agressive ou masse des parties molles | **Maligne jusqu'à preuve du contraire** : centre de référence, biopsie planifiée, bilan d'extension |

## PIÈGES

**Biopsie**
toujours planifiée avec le chirurgien du centre de référence (trajet)

**Contexte**
âge, siège (épiphyse, métaphyse, diaphyse), nombre de lésions orientent le diagnostic

**Ostéomyélite**
et histiocytose peuvent être agressives : clinique et biologie

**Lésions « à ne pas toucher »**
fibrome non ossifiant, îlot condensant typique : pas de biopsie

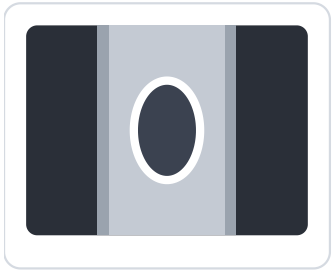
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

# Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS (suite)

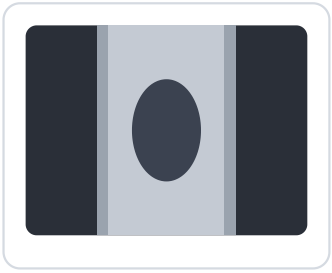
**ACR Bone-RADS v2023**
radiographie · score par points

## ATLAS VISUEL

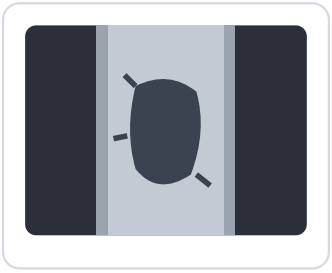
### Marges (Lodwick) et réactions périostées



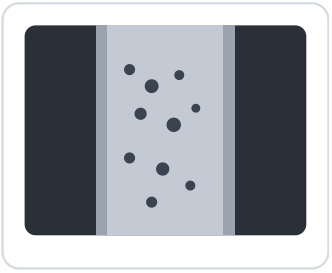
**IA**
géographique, bord scléreux · 1 pt



**IB**
bien limitée, sans sclérose · 3 pts



**II**
géographique mal limitée · 5 pts



**III**
mitée ou perméative · 7 pts



**Périostée solide**
non agressive · 2 pts



**Lamellée**
« bulbe d'oignon » · 4 pts



**Spiculée**
« feu d'herbe » · 4 pts



**Éperon de Codman**
agressive · 4 pts

Schémas simplifiés, non à l'échelle · os long en radiographie

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Bone-RADS**
Radiopaedia · score par points
radiopaedia.org/articles/bone-reporting-and-data

**Classification de Lodwick**
Radiopaedia · types de marges
radiopaedia.org/articles/lodwick-classification-

**Réactions périostées**
Radiopaedia · agressives ou non
radiopaedia.org/articles/periosteal-reaction

**Fibrome non ossifiant**
Radiopaedia · lésion « à ne pas toucher »
radiopaedia.org/articles/non-ossifying-fibroma-1

**Sources :** ACR Bone-RADS v2023 Assessment Categories – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Bone-RADS/Bone-RADS-v2023-... · Bone-RADS v2023 breakdown (Radiopaedia) – prod-images-static.radiopaedia.org/page_images/5146/R24-214_...

Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026